HIPERSENSIBILIDAD

¿Qué media la hipersensibilidad tipo I?

HIPERSENSIBILIDAD

Mecanismo de la hipersensibilidad tipo II

HIPERSENSIBILIDAD

Mecanismo de la hipersensibilidad tipo III

HIPERSENSIBILIDAD

Mecanismo de la hipersensibilidad tipo IV

HIPERSENSIBILIDAD

La prueba de Mantoux es una reacción tipo...

HIPERSENSIBILIDAD

Rechazo hiperagudo vs rechazo agudo

HIPERSENSIBILIDAD

Enfermedad del suero: tipo de hipersensibilidad

RINITIS ALÉRGICA

Tratamiento más eficaz de la rinitis alérgica

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

Anticuerpos IgG o IgM contra antígenos de la célula, con complemento o NK.

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

IgE unida a mastocitos y basófilos; libera histamina en minutos.

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

Linfocitos T; reacción tardía a las 48–72 horas.

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

Depósito de inmunocomplejos que activan el complemento.

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

Hiperagudo: tipo II (anticuerpos preformados). Agudo: tipo IV (linfocitos T).

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

IV (mediada por células).

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Esteroide intranasal (mometasona, fluticasona, budesonida).

RESPUESTA · HIPERSENSIBILIDAD

Tipo III (inmunocomplejos).

RINITIS ALÉRGICA

Rinitis persistente según ARIA

RINITIS ALÉRGICA

Desencadenante más frecuente de rinitis alérgica

RINITIS ALÉRGICA

Estudio que confirma rinitis alérgica en 2.º nivel

RINITIS ALÉRGICA

Único tratamiento que modifica la historia natural

RINITIS ALÉRGICA

Causa de rinitis medicamentosa

RINITIS ALÉRGICA

Signos de la cara del niño con rinitis alérgica

URTICARIA

Urticaria crónica: definición

URTICARIA

Causa más frecuente de urticaria crónica

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Ácaros del polvo doméstico.

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Síntomas ≥ 4 días por semana y ≥ 4 semanas.

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Inmunoterapia con alérgenos.

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Citología nasal con más de 10 % de eosinófilos.

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Saludo alérgico, pliegue nasal, ojeras y líneas de Dennie-Morgan.

RESPUESTA · RINITIS ALÉRGICA

Uso prolongado de descongestionantes tópicos (más de 3–5 días).

RESPUESTA · URTICARIA

Idiopática (urticaria crónica espontánea).

RESPUESTA · URTICARIA

Ronchas y/o angioedema por 6 semanas o más.

URTICARIA

Primer escalón del tratamiento de la urticaria crónica

URTICARIA

Si no hay control con dosis estándar...

URTICARIA

Tercer escalón de la urticaria crónica refractaria

URTICARIA

Datos de urticaria vasculítica

URTICARIA

Angioedema sin ronchas en paciente con enalapril

ANAFILAXIA

Tratamiento de primera línea de la anafilaxia

ANAFILAXIA

Dosis de adrenalina IM en el adulto

ANAFILAXIA

Sitio de aplicación de la adrenalina

RESPUESTA · URTICARIA

Aumentar el antihistamínico de 2.ª generación hasta 4 veces.

RESPUESTA · URTICARIA

Antihistamínico H1 de 2.ª generación a dosis estándar.

RESPUESTA · URTICARIA

Lesiones de más de 24 h, ardor y pigmentación residual; requiere biopsia.

RESPUESTA · URTICARIA

Omalizumab (anti-IgE).

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Adrenalina intramuscular.

RESPUESTA · URTICARIA

Angioedema por IECA (bradicinina); suspender el IECA.

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Cara anterolateral del muslo (vasto lateral).

RESPUESTA · ANAFILAXIA

0.01 mg/kg, máximo 0.5 mg (1 mg/mL), en el muslo; repetir cada 5–15 min.

ANAFILAXIA

Marcador de laboratorio que apoya el diagnóstico

ANAFILAXIA

¿Por qué se observa al paciente 6–12 horas?

ANAFILAXIA

Alergia a penicilina: precaución con...

ANAFILAXIA

Factores de mal pronóstico en anafilaxia

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Por el riesgo de reacción bifásica.

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Triptasa sérica.

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Asma no controlada, enfermedad cardiovascular, mastocitosis, uso de betabloqueadores.

RESPUESTA · ANAFILAXIA

Otros betalactámicos (posible reacción cruzada, sobre todo con cefalosporinas de 1.ª generación).